

времени». Для описания и уточнения отсылаю к другому источнику (Bezoari, Ferro, 1990a, 1991b, Ferro, 1993d,f).

В тот самый момент, когда поле оформляется, оно становится пространством-временем интенсивных эмоциональных возбуждений, в виде скопления β -элементов, которые, запуская и активируя α -функцию, начинают трансформироваться в α -элементы, то есть в основном в «визуальные образы» (Bion, 1962). И неважно, в чем эти образы воплотятся: в рассказе пациента, в реверии (reverie)⁸ или контрпереносе аналитика. Это описанное Бионом возникновение образов — результат сложных трансформаций, которые вместе с Бецоари мы попытались выразить с помощью метафоры мельниц (Bezoari, Ferro, 1992a): я привожу ее здесь в сжатом виде.

На аналитическом сеансе сталкиваются две α -функции: рассказ пациента (анекдоты, факты, воспоминания) — испытание для α -функции аналитика, которая будет вовлечена в процесс альфабетизации/семантизации коммуникации пациента. На аналитическом поле наиболее сложную работу можно выразить с помощью метафоры двух мельниц: одной — ветряной (для слов), а второй — водяной (для проективных идентификаций). В эти мельницы мы помещаем большие мешки с зерном (β -элементы) на помол, там они сначала превращаются в муку (α -элементы), а затем замешиваются в тесто и запекаются (сновидческое мышление наяву).

Между мельницами проходит оживленный обмен мешками (обмен сопровождается проективными идентификациями), обычно большая часть мешков передвигается в направлении от пациента к аналитику, за исключением тех моментов, когда последний закрыт или перегружен, — тогда поток мешков изменяет свое направление на противоположное (Ferro, 1987; Borgogno, 1992, 1994a).

Часто коммуникационный материал пациента настолько сырой, что в буквальном смысле нуждается в фильтрации, переработке с помощью молотилки, чтобы отделить зерно от шелухи, и задача α -функции состоит в том, чтобы эти элементы постепенно становились все более перемолотыми. Большая часть коммуникаций конкретного пациента (не переработанные, сырые коммуникации) передвигается по полю открыто (с помощью слов) или скрыто (проективные идентификации), и лишь небольшая доля коммуникаций появляется уже в трансформированном α -функцией пациента виде. После дальнейшей обработки аналитика образуется новая мука, и на сцену выступают «функциональные агрегаты»⁹ — результат психической работы обоих участников по проговариванию всего того, что происходит в поле и в паре.

Персонаж рассказа пациента на сеансе (понимаемый в нарратологическом смысле как главный герой, который может быть представителем животного мира или неодушевленным предметом) помимо

характеристик «героя внешней реальности» или «героя внутреннего мира» обладает качеством *«синкретического нарративного узла»* у конкретизирующего, контекстуализирующего, формирующего и определяющего происходящее в поле и придающего ему трехмерное выражение.

Таким образом, эмоционально-лингвистический текст сеанса выражает эмоции и чувства, представленные в переработанном виде, которые могут быть трансформированы, рассказаны и разделены собеседниками.

Суть этой концепции заключается в «сновидческом (онейрическом) мышлении наяву», то есть непрерывном «сновидении для-поддержания-бодрствования», в котором постоянно пребывает α -функция, создавая и упорядочивая α -элементы, т. е. «раскладывая по полочкам» все, что касается чувственно-перцептивно эмоциональных аспектов каждого момента нашего существования и взаимодействия.

Онейрическое мышление наяву отделяет сознательное от бессознательного, не позволяя бессознательному полностью захватить нас, помогает нам воспринимать опыт каждого конкретного момента жизни и метаболизировать этот опыт в реальном времени. А ночной сон позволяет нам увидеть результирующую некоего процесса, который развивается непрерывно (Bion, 1962).

Об онейрическом мышлении наяву мы получаем представление через «ближайшие нарративные производные» α -элементов, которые в то же время являются *сигналами в эмоционально-лингвистическом тексте* сеанса.

Сигналы текста становятся доступны восприятию, как только мы начинаем рассматривать все, что исходит из каждой точки поля (рассказы или сновидения пациентов, наш контрперенос, наши собственные сны, проективные идентификации и т. д.), как непосредственный пересказ эмоций и движений поля, а также успешных и неудавшихся трансформаций поля в единственно возможном терапевтическом направлении: $\beta \rightarrow \alpha$.

Эти сигналы поля подобны маркерам, которые позволяют нам удерживать трансформативное напряжение $\beta \rightarrow \alpha$, отмечают любое отклонение от направления трансформации как признак дисфункции поля.

Сигналы поля являются результатом психического функционирования пациента и аналитика, а также их сложного взаимодействия. С помощью этих сигналов, ежемоментно посылаемых эмоциональными силами поля, возможно значимое приближение к эмоциональной истине поля («О» для данной пары пациент-аналитик).

Естественно, эти сигналы можно трактовать и по-другому, в соответствии с альтернативными моделями,

относящими эти сигналы к внешней или внутренней реальности. Эти модели в аналитическом поле переходят одна в другую и подтверждают одна другую с любой теоретической вершины.

Перейдем теперь к рассмотрению проблем восприимчивости к анализу и завершения анализа на основе использования сигналов поля.

Анализируемость или выносливость

Литература, посвященная критериям анализируемости, весьма обширна, но сразу бросается в глаза дисбаланс между изобилием написанных на эту тему работ и недостатком совпадающих точек зрения.

Прежде всего поражает прямое несоответствие между развитием терапевтических моделей и расширением названных критериев: фактически, аналитики, которые дальше всех продвинулись в лечении тяжелой патологии, только слегка касались проблемы восприимчивости к аналитическому лечению.

На мой взгляд, гораздо целесообразнее ввести критерий выносливости аналитика, в том смысле, что каждый аналитик, полагаясь на свой собственный опыт, должен четко понимать психическое функционирование, степень толерантности к риску и фрустрации, и то, насколько он сам способен переносить анализ. Также нужно иметь в виду степень выносливости аналитической модели, которой он располагает. Зачастую аналитик работает на грани вытеснения, способствуя построению и формированию

«аппарата по думанью мыслей» (Bion, 1962) еще до того, как эти мысли будут подвержены психической переработке, и даже помогая развитию самой α -функции, пусть даже и дефицитарной, в ее зачаточном виде.

Что касается обзора наиболее значительных работ в этой области, я рекомендую исследование Лиментани (1972) и его дополненное издание (1998b), а также замечательный обзор Этчегоэна (1986).

Мне кажется необходимым подчеркнуть, что внимание исследователей во многом сместилось с изучения особенностей пациента на изучение особенностей пары и взаимодействия между данным пациентом и данным аналитиком.

В то же время с понятием анализируемости (имеется в виду возможность выздоровления, т. е. достижения цели анализа) слилось, а во многом и заменило его понятие пригодности к анализу (т. е. способности находиться в анализе и переживать процесс трансформации) (Limentani, 1972) и понятие доступности анализу, на основе которого пациенты делятся на легко доступных и трудно доступных (Joseph, 1985).

Стоит также упомянуть о «тревожном» отношении многих аналитиков к возможному прекращению анализа (как если бы понятие «анализируемости» давало стопроцентную гарантию успешного прохождения всех предусмотренных фаз анализа),

вместо того чтобы считать анализ функциональным в тех пределах, в которых он может быть осуществлен. Говоря словами Блегера (Bleger, 1967), один анализ может с успехом завершиться там, где другие бы только начались¹⁰.

Озабоченность вызывает и бесконечность анализа, воспринимаемая скорее как безрезультатность, чем как необходимость непрекращающегося лечения из-за специфики патологии пациента и аналитического поля, анализа-диализа; а порой такой анализ может быть нужным.

Из всех пациентов, когда-либо просивших меня об анализе, я отказал, располагая свободным местом, только двоим. Оба случая произошли в начале моей психоаналитической практики. Первый пациент предложил мне для анализа эмоциональную и экзистенциальную тематику, с которыми я незадолго до этого работал и еще не чувствовал себя достаточно окрепшим, чтобы снова вернуться к ней с другим человеком. Второй пациент, высокий и плотный мужчина, рассказал мне на сеансе, что ему казалось, будто за ним кто-то наблюдает. Когда это подозрение превратилось в уверенность, он остановил машину и избил до крови своего гипотетического преследователя. Мне показалось это достаточным аргументом в пользу того, чтобы не «наблюдать» этого пациента.

Во всех остальных случаях, если у меня было место, я никогда не отказывал пациенту, считая его «не

анализируемым» или слишком тяжело нарушенным. За это я порой расплачивался усталостью и психическим страданием, что немало. Однако эта позиция позволяла выходить за пределы уже освоенных территорий.

Для меня остается загадкой решение взять пациента, когда для него объективно нет места¹¹: это случается с теми пациентами, которые предлагают тематику, близкую в тот конкретный момент к теоретическим и практическим интересам аналитика. Тогда последний с помощью такого анализа сможет продвинуться в исследовании неизведанных прежде пластов, темных мест или просто не разработанных собственной психикой вопросов (Meotti, 1987).

Аналитик может опасаться и возможного ухудшения состояния пациента. С одной стороны, такое ухудшение свидетельствует о неподходящей технике ведения анализа (это выражается в многочисленных психотических переносах, негативных терапевтических реакциях и частых перерывах (De Masi, 1984; Gagliardi Guidi, 1992; Conforto, 1996), с другой стороны, ухудшение необходимо для выявления скрытых и заблокированных психических состояний.

Пюже и Вендер (Puget, Wender, 1987) считают, что анализ заключается в активации — часто в экстремальной ситуации — психоаналитической функции, которая способна «понимать и семантизировать бессознательное, не понимаемое и не

мыслимое до этого момента, то есть облегчать психическую боль».

Естественно, аналитик должен проанализировать свои возможности и решить, может ли он взять еще одного пациента или этого конкретного человека. Бывает, что мы отказываем конкретному человеку, потому что нет места для еще одного пациента.

Но бывает, как я уже упоминал ранее, и наоборот. Не имея места для еще одного пациента, мы находим его для данного конкретного человека. С классической точки зрения, такие озарения могли бы послужить хорошим предлогом для отказа пациенту, вызывающему контртрансферентную реакцию, но как и зачем сопротивляться? Во время анализа мы еще успеем пожалеть о своем согласии. Случается и обратная ситуация, когда пациент, которого мы соглашаемся принять только потому, что было свободное место, заставляет в процессе работы пережить страстный и увлекательный анализ. Мне кажется, это лишний раз доказывает тот факт, что в одном анализе потенциально содержится бесконечное количество смыслов для раскрытия и миров для активации.

Нет ничего наивнее, чем полагать, что первая встреча — наиболее нейтральна и что во время первой встречи аналитик в основном лишь вслушивается в историю и всматривается в мир пациента. На деле уже в процессе телефонного разговора и со стороны

аналитика, и со стороны пациента начинают оформляться фантазии «пары». Как точно заметил Баранже, эти фантазии стремительно формируются уже на первом сеансе. Более того, *модель слушания*, если аналитик не отдает себе в этом отчета, подчиняет себе аналитическое поле и в итоге подтверждает установки аналитика через формирование навязываемых пациенту микротрансформаций в галлюцинозе. В этих случаях модель злоупотребляет коммуникацией пациента, «прочитывая ее» однозначно. Интерпретативная колонизация создает диктатуру несуществующего, избегая болезненного опыта фрустрации перед пустотой незнания и риска надолго задержаться в параноидно-шизоидной позиции (PS), в ожидании того, что поле — «истинная матрица возможных историй» (на основе эмоциональных геномов аналитика и пациента и способностей к трансформации) — активирует «историю», которую нельзя так просто заранее предугадать. Я считаю, что с самого первого сеанса присутствует постоянное колебание между двумя аналитическими функциями. Одна из них — «негативные способности» аналитика (Bion, 1970), которые влекут за собой его умение пребывать в сомнении, в параноидно-шизоидной (PS) позиции, способствуя рождению бесконечного количества потенциальных историй (или смыслов). Вторая — решение в пользу «избранного факта». Оно влечет за собой выбор интерпретативной гипотезы, рождающейся

из эмоции, которая объединяет все рассеянное в параноидно-шизоидной позиции многообразие в гештальт, отменяющий некоторые смыслы, допуская один превалирующий, и однозначно реорганизует под определенным углом зрения все то, что оформилось в аналитическом поле. Эта операция происходит на депрессивной позиции (D) и включает скорбь по всему тому, чего нет.

В нарратологии этот прием определяется понятием «открытое произведение» — введение сюжетных отступлений и вставных историй, раскрывающих смысл главной линии повествования, что Дидро эффективно продемонстрировал в своем «Жаке Фаталисте и его хозяине» (Есо, 1979; Ferro, 1992).

Здесь я бы хотел привести короткий пример.

Оргазм и школьный табель Кармен

Первое, что я узнал о Кармен (молодой девушке, не итальянке), — она не испытывает оргазма от пенетрации. Меня поразило, что она решила начать именно с этого.

Она рассказывает мне о своей жизни, которой не совсем довольна, и об оставленной в одном европейском городе семье. Ее рассказ сопровождается детскими воспоминаниями и описанием ее характерной особенности — постоянной озлобленности. Кармен утверждает, что стала такой в детстве, после того как пережила одно разочаровавшее ее событие. Она принесла отцу на подпись табель с очень плохими

оценками, будучи уверенной, что он рассердится и накажет ее. Она очень расстроилась и разозлилась из-за того, что отец поставил подпись, даже не взглянув на оценки и, следовательно, никак не прокомментировав их. Затем она рассказывает о поверхностных отношениях с матерью и о переживаниях, связанных со сменой политического режима в родной стране.

Что думать об этом интервью? Как интерпретировать персонажей? Их можно трактовать с точки зрения исторической достоверности и принадлежности к внешней реальности, в контексте семейного романа. Тогда мы вправе рассматривать сексуальные проблемы Кармен как проблемы женственности, страха кастрации, эдиповой, доэдиповой тематики и так далее.

Однако персонажей можно также интерпретировать как способ коммуникации, диалект, на котором пациент рассказывает об эмоциональных фактах внутренней жизни. «Оргазм от пенетрации» может нести смысл «глубоких интимных отношений», а история со школьным табелем может служить прототипом любых разочаровывающих и фрустрирующих отношений, как если бы Кармен сразу заявила: «Вот в чем моя проблема: близкие и глубокие отношения никогда не доставляют мне удовольствия, но только разочарование и злобу»; сексуальная проблема может быть примером,

с помощью которого пациент раскрывает еще более глубокую тематику.

Здесь также мог бы присутствовать еще один уровень интерпретации, если бы мы с самой первой встречи поместили персонажей и сюжеты в контекст наших отношений: уже по телефону я сказал Кармен, что у меня нет места для нового пациента и я мог встретиться с ней только для интервью. Ничего кроме огорчения и злости она не могла почувствовать по отношению к тому, кто не выказывал никакого особенного интереса к ее «плохим оценкам», и, разумеется, мой ответ не доставил ей удовольствия.

Любое из этих прочтений, на мой взгляд, представляет собой колонизацию текста и пациента. Альтернатива заключается в том, чтобы создать во время сеанса модель, способную абстрагироваться от теории. Пусть произойдет первое название или осмысление неизвестного и никогда ранее не мыслимого (по крайней мере, для Кармен и для меня) — того, о чем мы не можем ничего знать, пока оно не воплотилось. По сути, это то, о чем писал Блон, говоря об использовании «модели», создаваемой прямо на сеансе, и о бытии аналитика без «памяти и желания» (Blon, 1962, 1970). Нужно опираться не на расшифровывающие интерпретации, а на собственные «негативные способности» (Blon, 1970), и смотреть, каким трансформациям подвергается данная история, рассказанная на данном диалекте конкретного

пациента, в зависимости от взаимодействия психики пациента с психикой аналитика в аналитическом поле, которое они вместе создают. Это поле понимается как место-пространство, где возникают и активируются возможные истории (исходя, разумеется, из эмоциональных ингредиентов, которые приносит пациент).

С этой точки зрения, важно рассматривать персонажей сеанса в максимально широком диапазоне: от исторических персонажей, проникших во внутренний мир пациента и его отношения с людьми, до голограмм аналитического поля, в том числе n -комбинаторных, не определяемых априорно.

Я полагаю, следовательно, что критерий анализируемости апостериорен. В том смысле, что мы не знаем заранее, какие «истории» (пары, внешнего мира, истории) воплотятся, мы можем только делать предположения (не более точные, чем прогноз погоды) о волнениях, которые будут активизированы в поле, и вопрос здесь может звучать так: насколько « α -функция поля» и «аппарат по думанью мыслей» поля окажутся способными не разрушиться (и следовательно, не исчезнуть), а подвергнуть трансформации β -элементы поля.

Единственный аспект, хотя и не дающий критерия анализируемости, который я нахожу полезным, касается оценки (с самой первой встречи) возможностей трансформативной работы на сеансе¹².

Имеется в виду та способность формировать образы, сюжеты и фантазии, которая активируется в паре и является предвестником ее плодотворной работы. Очевидно, что если этого не происходит, возникает проблема, требующая решения.

Вспомним, что Блон в своей решетке отдал вторую линию под «ложь» — то есть все то, что нас «защищает» от неизвестного. Именно неизвестности мы больше всего боимся, пытаемся всячески ее избежать, отогнать от себя или глубоко запрятать. Я думаю, что любой «трудный» или не поддающийся анализу (согласно нашим параметрам) пациент всего лишь указывает нам на свои неизведанные стороны и неизведанные стороны нас самих, а также наших теорий (Gaburri, Ferro, 1988).

Я не могу не упомянуть о притче про лжеца (Bion, 1970), и ко всем ложным истинам, к которым мы взываем, чтобы защитить себя, мне бы хотелось добавить также многое из того, что написано о критериях анализируемости.

Каждый новый пациент несет в себе риск для психической жизни аналитика. Разумеется, этот риск уменьшается, если аналитик удовлетворяется только ролью археолога или расшифровщика фантазий «этого конкретного» пациента.

Разумеется, тяжелые пациенты представляют собой угрозу для аналитика, так как с ними идет работа по обнаружению и метаболизации очень примитивных и зачастую катастрофических тревог, которые тем или

иным путем попадают в аналитическое поле. То же самое относится и к тяжелым психосоматическим заболеваниям, в работе с которыми необходимо проходить путь от соматического к психическому.

Опасность может представлять сам масштаб активируемого психического страдания аналитика (вспомним слова Фрейда о потребности каждого аналитика в периодическом «ремонте» и слова Биона о пациентах, наносящих повреждения психике аналитика).

Следующая «опасность» касается роста психики аналитика: страдание, связанное с ростом области осмысления — то есть в буквальном смысле расширения психики. Еще одна опасность — на этот раз и для пациента тоже — заключается в том, что теории могут воздвигаться как защита против осмысления, что, впрочем, может произойти и с интерпретациями.

Окончание анализа

Разумеется, литература о критериях окончания анализа весьма богата. Желаям расширить свои познания в данной области я рекомендую работы Этчегоэна (Etchegoyen, 1986), Преве (Preve, 1994) и Де Симоне (De Simone, 1994).

Для окончания анализа актуально все то, о чем я говорил выше. Если мы рассматриваем анализ в рамках «поля», значит, именно в поле и появится «сигнал» об окончании анализа. Этот сигнал может появиться в любой части поля: в контрпереносе, сновидениях

контрпереноса, возможно, об этом событии начнут «сигнализировать» рассказы или персонажи пациента, *то есть окончание анализа будет определено не на основе теории, которая его предвидит, а изнутри модели, которая с ним согласуется* (Bion, 1962).

Различие между моделью и теорией Бион очень ясно определяет в работе «Научение через опыт переживания» («Learning from Experience»): теория — нечто насыщенное, она рождается из высокой степени абстракции. Если теория используется на сеансе, она может злоупотреблять материалом. Модель — нечто ненасыщенное, каждый день изобретаемое заново, модель — это сиюминутное открытие, сделанное во время сеанса, вне сеанса оно может обобщиться в теорию, но на сеансе модель уникальна и неповторима.

Мне хотелось бы также упомянуть еще об одной переменной поля. Поле строится на основе психической жизни пациента и аналитика, взаимодействия их защитных механизмов, переносов и проективных идентификаций; следовательно, окончание анализа — нечто очень специфическое в каждом отдельном случае и для каждой конкретной пары.

Для меня окончание анализа — «событие», характерное именно для данного анализа; бывает, что потом я нахожу общие элементы, но это всегда приходит апостериорно. Во время анализа всегда преобладает неожиданность и непредсказуемость